

每週心血管期刊文獻回顧

2026-05-10 ~ 2026-05-17

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

讀書會共筆・醫療專業教學參考

涵蓋：NEJM・Lancet・EHJ・JACC family・Circulation family・EuroIntervention

本週主題

「重新檢視老藥、嚴格看待新藥」

- **老藥回歸**：DIGIT-HF AF subgroup + DECISION 兩篇 EHJ 文章重新確立 **digitoxin/digoxin** 在 HFrEF 的地位
- **新藥落地**：tonlamarsen (RAAS antisense)、XXB750 (NPR-1 agonist) 兩項 phase 2 BP 試驗 **target engagement** 達標卻無臨床效益
- **結構介入**：DOUBLE-CHOICE 證實 ACURATE neo2 在選定解剖優於 Evolut (PPM 11.2% vs 26.5%) ——但 valve 已下市
- **新概念**：sotatercept 跨界 HFpEF-CpcPH 首例 phase 2 positive (CADENCE)

Top 5 Picks 一覽

#	試驗	期刊	結果	關鍵數字
1	DOUBLE-CHOICE	EuroIntervention	✓	30d composite 15.4% vs 30.4% (p<0.001) ; PPM 11.2% vs 26.5%
2	DIGIT-HF AF subgroup	EHJ	✓	主試驗 HR 0.82 (95% CI 0.69-0.98) ; AF 與 sinus 一致
3	CADENCE (sotatercept)	Circulation	💡	PVR -1.02 WU (p=0.004) in HFpEF + CpcPH
4	TAPIS (DAPT+IVT)	Lancet	✓	90d mRS 0-1: 68.7% vs 62.0%, RR 1.11 (p=0.0089)
5	KARDINAL (tonlamarsen)	JACC	✗	ΔSBP -0.1 mmHg (p=0.97) 雖再壓 angiotensinogen -44%

NEJM

ORIENTAL-MeVO — Thrombectomy for Medium-Vessel Stroke

Hu W, et al. *N Engl J Med* 2026;394(19):1894-1904.

項目	內容
設計	中國 48 中心 open-label RCT，blinded outcome
族群	n=563；急性 MeVO 缺血性中風，NIHSS ≥6，發病 24h 內
介入	Thrombectomy + medical mgmt vs medical mgmt alone
Primary	90d mRS 0-2：58.6% vs 46.6%，adjusted RR 1.24 (1.07-1.44)，p=0.004 ✓
安全	Symptomatic ICH 4.7% vs 2.2%；90d mortality 11.1% vs 10.2% (NS)

Thrombectomy 適應症由 LVO 延伸至 MeVO，但症狀性 ICH 雙倍——須謹慎挑選 NIHSS ≥6 患者

Lancet

TAPIS — DAPT + IV Thrombolysis 改善中度中風預後

Wang A, et al. *Lancet* 2026;407(10542):1919-1928.

項目	內容
設計	中國 60 中心 double-blind, placebo-controlled RCT
族群	n=1,382 ; IVT-treated stroke · NIHSS 4-10
介入	發病 6h 內加 ticagrelor + aspirin × 7d vs placebo (後續 aspirin × 83d)
Primary	90d mRS 0-1 : 68.7% vs 62.0% , RR 1.11 (1.03-1.20) , p=0.0089 ✓
安全	36h symptomatic ICH 0.9% vs 0.7% , RR 1.20 (0.37-3.93, NS)

IVT 後 6 小時內加上 7 天 DAPT 是新策略——對中等嚴重度 stroke 額外功能效益顯著

SURMOUNT-MAINTAIN — Tirzepatide 維持減重

Horn DB, et al. *Lancet* 2026 (online).

項目	內容
設計	Phase 3b RCT ; 60w open-label 減重 + 52w double-blind 維持
族群	n=378 (達 MTD 後 3:3:2 分組) ; BMI ≥30 或 ≥27+ 共病
比較	繼續 MTD vs 降至 5 mg vs 換 placebo × 52 週
112 週體重變化	MTD -21.9% vs 5 mg -16.6% vs placebo -9.9% (p<0.0001) 

減重後停藥必回升；繼續 tirzepatide MTD 維持最佳，降至 5 mg 仍優於 placebo——**obesity 是慢性病**

European Heart Journal

DIGIT-HF AF subgroup — Digitoxin 在 HFrEF (AF 與否 皆有效)

Bavendiek U, et al. *Eur Heart J* 2026 (online).

項目	內容
背景	主試驗 (NEJM 2025, n=1,240) : digitoxin vs placebo
主試驗 primary	All-cause death + HF 住院 HR 0.82 (0.69-0.98), p=0.03 ✓
本次分析	Prespecified subgroup : 依基線 AF 狀態
主要訊息	Digitoxin 效益 不受 AF 狀態影響 ——sinus 與 AF 皆有一致改善

強心劑回到 HFrEF 武器庫 ; 台灣 digoxin 仍可使用但須監測 narrow therapeutic window

DECISION — 停 digoxin 反惡化 (Don't stop!)

van der Meer P, et al. *Eur Heart J* 2026 (online).

項目	內容
設計	DECISION trial 子分析：blinded withdrawal at end-of-study
族群	n=587 已治療中位 36.5 個月
結果	撤 digoxin 後 CV death/worsening HF 由 5.7 → 42.8 events/100 PY ；撤 placebo 維持 5.9
Risk	撤 digoxin RR 7.37 (1.56-34.88), p=0.012 ✗ (harm signal)
生理	HR ↑、SBP ↓、NT-proBNP ↑

已使用 digoxin 的 HF 病人 **不要隨意停藥**；deprescribing 需謹慎

SPRINT/ACCORD pooled — BP Variability 預測 CV 事件

Zhao W, et al. *Eur Heart J* 2026 (online).

項目	內容
族群	n=18,415 (IPD) · 中位 12 次 BP 量測 · 追蹤 3.6 年
結果	SBP-VIM 最高 vs 最低 tertile HR 1.15 (1.00-1.32)
形狀	BPV 與 MCE 呈 J-shape (過低或過高 BPV 均有害)
Prognostic	BPV 預測力 $\approx$ mean SBP

未來 HTN 管理應同時關注「平均」與「變異性」

EAPCI/EBC Consensus — LM PCI 必須用 Intracoronary Imaging

Johnson TW, et al. *Eur Heart J* 2026 (online).

- **核心建議**：所有 LM bifurcation PCI (ACS 與 CCS) 皆應使用 **IVUS or OCT**
- 美國與歐洲 guidelines 已將 LM imaging 列為高等級建議
- 本 consensus 提供 planning、guidance、optimization 操作層面指南
- 與本週 EuroIntervention 的 **OCTOBER LM substudy** 相互呼應 (OCT vs angio: MACE 14.4% vs 18.4%, HR 0.78, NS)

LM bifurcation 不再「能 image 就 image」，而是「**必須 image**」

EJ — 其他焦點 (1/2)

主題	重點	連結
MOMENTUM-3 RAASi 分析	RAASi 與 LVAD 較低 HRAE 相關 (aRR 0.83)	DOI
ACHD 首次 AMI	預後與一般族群相似 (Holmgren et al.)	DOI
AMI 機械併發症 SOTA	Free-wall rupture / pseudoaneurysm / PMR	DOI
HF 盛行率 ≈ 6 億?	Cleland 評論：從推估到證據	DOI

EHJ — 其他焦點 (2/2)

主題	重點	連結
CAD 分子機轉	Atherosclerosis biological insights (von Scheidt & Kovacic)	DOI
AI in CV Medicine	Crea editorial : 「nothing will be as it was」	DOI
MTMR4 與 LQT 風險	LQT1 vs LQT2 gene-specific 影響	DOI
FINEARTS-HF 子分析	病毒呼吸道感染與 HFpEF 預後	DOI
AF burden vs density	量化 AF 新指標	DOI

JACC Family

KARDINAL — Tonlamarsen 在 uncontrolled HTN ✕

Laffin LJ, et al. *J Am Coll Cardiol* 2026;87(18):2508-2520.

項目	內容
設計	Phase 2 RCT · n=198 randomized after single-dose run-in
介入	Tonlamarsen 90 mg monthly × 4 doses vs placebo
Δangiotensinogen	Monthly -67.2% vs single-dose+placebo -23.0% (diff -44.1% , p<0.0001) ✓
ΔOffice SBP	Monthly -6.7 mmHg vs single-dose+placebo -6.7 mmHg (diff -0.1 mmHg , p=0.97) ✕

Target engagement ≠ BP benefit——RAAS 上游 antisense 在已用多種藥物族群達 ceiling effect

HM-APOLLO 301/302 — Single-Pill Low-Dose Triple



Sung KC, et al. *J Am Coll Cardiol* 2026;87(18):2392-2411.

項目	內容
設計	韓國 Phase 3 RCT · n>1,000 ; 輕中度 HTN
介入	LDC-ALC (amlodipine 1.67 + losartan 16.67 + chlorthalidone 4.17 mg) vs amlodipine 5 mg / losartan 50 mg
Study 301	LDC-ALC vs amlodipine ΔSBP -19.1 vs -19.9 (non-inferior, p=0.495)
Study 302	LDC-ALC vs losartan ΔSBP -19.9 vs -16.4 (superior , p=0.037) 

超低劑量三合一單顆作為 initial therapy 安全有效，比 losartan 單藥更佳

XXB750 — NPR-1 Agonist 在 resistant HTN ✕

White WB, et al. *J Am Coll Cardiol* 2026;87(18):2373-2387.

項目	內容
設計	Phase 2 RCT · n=189 · 4 dose levels (30/60/120/240 mg monthly SC) × 12 週
族群	Resistant HTN · 24h SBP ≥135 mmHg 已用 3-4 種藥
藥理	XXB750 顯著增加 cGMP (dose-dependent) · target engagement 達標
Primary	24h SBP 變化：所有劑量與 placebo 無差異 ✕
安全	不良事件略增

NPR-1 agonist 路徑暫時失敗；resistant HTN 仍以 RDN 與 spironolactone 為主流

JACC — POTS Ivabradine vs Propranolol

Uppal J, et al. *J Am Coll Cardiol* 2026 (online).

項目	內容
設計	Crossover RCT · 28 名女性 POTS (平均 33 歲)
介入	Ivabradine 5 mg BID vs propranolol 10 mg QID vs placebo · 各 4 週
主要結果	10 分鐘 head-up tilt Δ HR peak : ivabradine 24 , propranolol 25 , placebo 33 beats/min ($p_{\text{drug}} < 0.001$)
比較	兩活性藥物效果相當 · 皆降至 POTS 診斷閾值 (Δ HR < 30) 以下

Ivabradine 與 propranolol 都有效；ivabradine 副作用較少（無 fatigue/depression），可為 first-line

EAST-AFNET 4 CKD subgroup — ERC 也適用 CKD

Schenker N, et al. *J Am Coll Cardiol* 2026 (online).

項目	內容
設計	EAST-AFNET 4 prespecified secondary ; n=2,742 ; 23% CKD (GFR <60)
族群	Recently diagnosed AF + stroke risk factors
ERC effect	No CKD HR 0.84 (p<0.001) ; CKD HR 0.67 (p<0.001)
Interaction	P_interaction = 0.133 (一致效果) 
安全	CKD 增加安全事件但與 ERC 無交互作用

CKD 不應成為延後 early rhythm control 的理由——CKD + AF 患者更應積極考慮

LIFE-BTK 3-Year — DRS 在 CLTI 持久優勢

Parikh SA, et al. *J Am Coll Cardiol* 2026 (online).

項目	內容
設計	n=261 · DRS (Esprit BTK) vs PTA (2:1) ; CLTI + infrapopliteal
3-yr Primary efficacy	KM 59.5% vs 44.8%, p=0.0025 
Restenosis	38.0% vs 49.0%
CD-TLR	10.2% vs 18.4% (adjusted HR 0.46, 95% CI 0.22-0.97)
安全	Limb salvage 93.8% vs 95.7% (comparable)

DRS 在 BTK CLTI 提供持久的 patency 與較少 re-intervention——3 年成熟證據支持取代 PTA

JACC — Multiarterial Grafting IV Analysis ✕

Schaffer JM, et al. *J Am Coll Cardiol* 2026 (online).

項目	內容
設計	Medicare 1.29M CABG (2001-2019) ; surgeon MAG rate 為 IV
傳統 risk-adjust	MAG 10.74 yrs vs SAG 10.33 yrs (+0.41 yr)
IV model	MAG 10.38 yrs vs SAG 10.38 yrs (Δ 0.01 yr) ✕
結論	觀察性研究高估 MAG 效益——unmeasured confounding 主導

MAG 在 selected patients 合理，但**不應 routine 推行於所有 CABG**——與 ROMA/ART 等 RCT 一致

JACC — 高血壓主題刊：其他焦點

主題	重點	連結
AHA Workshop BP 量測	跨年齡 BP 評估更新報告	DOI
Global Hypertension 2000-2020	知曉率、治療率、控制率 disparities	DOI
BETTER-BP	Behavioral economics 改善 adherence	DOI
STEP trial BP trajectory	老年高風險患者 BP 軌跡與預後	DOI
PM 與 HTN 死亡	中國 2.1M 案例 case-crossover	DOI

JACC — 其他焦點

主題	重點	連結
Istaroxime SEISMiC pooled	心因性休克 hemodynamic + arrhythmia 改善	DOI
Door-to-Lactate Clearance	Lactate clearance 為休克復甦關鍵 surrogate	DOI
CPVT LCSD	左心交感切除降低 CPVT 患者 ICD 需求	DOI
HDP in US 2016-2024	妊娠高血壓盛行率持續上升	DOI
CD36 LOF 與 DCM	All of Us : CD36 LOF 與 dilated cardiomyopathy	DOI

Circulation Family

CADENCE — Sotatercept 在 CpcPH-HFpEF

Gomberg-Maitland M, et al. *Circulation* 2026;153(19):1446-1459.

項目	內容
設計	Phase 2 RCT ; n=164 ; sotatercept 0.3 vs 0.7 mg/kg vs placebo q3w × 24w
族群	HFpEF + combined post+precapillary PH (mPAP ↑, PAWP ↑, PVR ↑)
Primary Δ PVR	0.3 mg/kg -1.02 WU (p=0.004) ✓ ; 0.7 mg/kg -0.75 WU (p=0.024) ✓
次要	mPAP -9.2 mmHg ; PAWP -2.5~-3.0 ; 6MWD +20 m (0.3 mg/kg)
安全	Hgb ↑ 、腹瀉

PAH 之活素訊號抑制劑跨界進入 HFpEF-CpcPH——首個 phase 2 positive proof-of-concept ;
Merck 規劃 phase 3

AGENT 上市後 — DCB 在美國快速擴張

Lalani C, et al. *Circ Cardiovasc Interv* 2026 (online).

項目	內容
期間	2024 年 4 月 FDA 核准 ~ 2025 年 6 月
數量	n=14,946 DCB · 12,337 患者 · 704 中心
ISR PCI DCB 使用	<1% → 17.5%/月 快速擴張
特徵	DCB 群 imaging 使用 54.5% (vs DES 35%) · atherectomy 14.9%
安全	院內不良事件率與 DES 相當 (SMD <10%)

DCB 已成為 US ISR 主流 ; non-ISR off-label 使用亦增長

RESTORE FIH — Laser/Optics IVL for Calcified Coronary 💡

Price MJ, et al. *Circ Cardiovasc Interv* 2026 (online).

- 首次人體研究
- 機制：**雷射 + 光學介導**衝擊波 (vs 現行電液壓 IVL , 如 Shockwave Coronary IVL)
- 適應症：嚴重鈣化冠脈病灶
- 安全性與初步成效獲確認
- 須後續大型試驗驗證

鈣化病灶介入工具持續擴展——除了現行 IVL/Atherectomy 之外的新選項

AD-HOC Registry — PPM after TAVR in Sievers BAV

Fabris T, et al. *Circ Cardiovasc Interv* 2026 (online).

項目	內容
設計	Retrospective multicenter (24 centers), n=781
族群	嚴重 AS + Sievers type 1 BAV 接受 TAVR (2016-2023)
mPPM vs pPPM	22% vs 8% (p<0.001) ; mPPM 多於 pPPM
風險因子	Balloon-expandable valve 與 mPPM 及 pPPM 皆獨立相關
Small annulus ($\leq 430 \text{ mm}^2$)	pPPM 與 all-cause mortality 相關 (但與 CV mortality 無關)

BAV TAVR 在 small annulus 須更謹慎的 sizing 計畫

Circulation 其他焦點

主題	重點	連結
AHA 2026 — 二級預防 after CABG	更新 GDMT、LDL、cardiac rehab 重點	DOI
Laroprovstat (AZD0780)	首個口服小分子 PCSK9i，phase 1 LDL-C 降 80%	DOI
FOURIER + FOURIER-OLE	Evolocumab 早期 vs 晚期啟動與動脈瘤事件	DOI
Pediatric HCM Massive LVH	兒童 HCM 預後分析 multi-registry	DOI
AHA — Pediatric ADHF	兒童急性失代償性 HF 評估管理	DOI
AHA — RV Failure 評估	RV failure 分子、代謝、影像方法	DOI

EuroIntervention (Mainz 2026 Issue)

DOUBLE-CHOICE — ACURATE neo2 vs Evolut TAVI

Feistritzer HJ, et al. *EuroIntervention* 2026;22(10):555-565.

項目	內容
設計	德國 10 中心 open-label, 2×2 factorial, non-inferiority RCT ; n=835
族群	嚴重 AS · selected anatomies (解剖適合 ACURATE neo2)
Primary	30d composite (死亡+stroke+modPVR+PPM) : 15.4% vs 30.4% , p_non-inf<0.001, p_diff<0.001 
主要差異	PPM 11.2% vs 26.5% (p<0.001)
Mod/Severe PVR	1.3% vs 1.7% (兩者皆低)
 重要背景	ACURATE neo2 已於 2026/05 由 BSC 自市場下架

「**ACURATE 平台設計理念**」 (supra-annular 、 low radial force) 仍是未來 TAV 設計重要參考

GLUCO-TAVI — Glucocorticoids 預防 TAVI 後 PPM ✕

Fuertes-Kenneally L, et al. *EuroIntervention* 2026;22(10):545-554.

項目	內容
設計	Pilot PROBE RCT ; n=100 ; 西班牙單中心
介入	Methylprednisolone 7 mg/kg + prednisone 5d vs 標準照護
1m PPM	8% vs 16% , RR 0.50 (0.16-1.55) , p=0.23 (NS but trend)
1y PPM	RR 0.67 (0.26-1.73, NS)
安全	無安全性問題

數值朝預期方向但 sample 不足——須大型 RCT 確認 ; anti-inflammatory 預防 TAVI conduction disturbance 仍合理假設

SPYRAL 36-Month — RDN 長期 BP 效益

Kandzari DE, et al. *EuroIntervention* 2026;22(10):585-593.

項目	內容
族群	n=2,137 SPYRAL programme pooled
基線	OSBP 163, ASBP 152, 藥物 3.8 種
36 個月	Δ OSBP -18.1 mmHg , Δ ASBP -13.3 mmHg (p<0.0001)
藥物	由 3.8 → 3.5 種 (NS but trend ↓)
Clinical responder	88% 達 ≥ 10 mmHg OSBP 或 ≥ 5 mmHg ASBP 或 ≥ 1 種藥物減量

RF-RDN 效益**耐用 3 年**——支持作為 uncontrolled HTN guideline-recommended therapy

OCTOBER LM substudy — OCT vs Angio in True LM Bifurcation

Holck EN, et al. *EuroIntervention* 2026;22(10):566-574.

項目	內容
設計	OCTOBER trial true LM bifurcation 病灶 n=227
可行性	98% pre-stenting + 96% final pullback 完成
限制	近段 LM ostium 顯影率 43% (受 guide catheter shadowing 影響)
MACE	OCT 14.4% vs Angio 18.4% · HR 0.78 (0.39-1.51) , NS

與主試驗方向一致；LM ostium 仍是 OCT 限制——與 EAPCI/EBC consensus 互相參照

Emilsson — Ticagrelor vs Clopidogrel in DOAC + ACS PCI

Emilsson OL, et al. *EuroIntervention* 2026;22(10):575-584.

項目	內容
設計	SWEDHEART registry cohort, n=3,708, 2014-2022
族群	DOAC + ACS PCI · dual antithrombotic (無 aspirin)
MACE	16.7% vs 16.6%, aHR 1.02 (NS)
Bleeding	4.9% vs 3.7%, aHR 1.53 (1.06-2.22) ✕
Mortality	6.6% vs 6.2% (NS)

Clopidogrel 優於 ticagrelor——無 ischemic 好處但出血明顯增加，與 ESC 2024 ACS guideline 一致

EuroIntervention 其他焦點

主題	重點	連結
TAVI timing in AS 回顧	早期介入 vs symptomatic 介入 (Craig et al.)	DOI
TAVI 後發炎 editorial	Inflammation as therapeutic target post-TAVI	DOI
Prasugrel vs ticagrelor 辯論	ACS 中應該優先選擇哪一個 ? pros and cons	DOI
DOUBLE-CHOICE editorial	「不必要的告別」——對 ACURATE neo2 下市反思	DOI
Anticoag + ACS antithrombotic	"Sledgehammer or scalpel" editorial	DOI

整合 Take Home

本週 5 大臨床啟示

Pearl 1 — 老藥重生：DIGIT-HF + DECISION 共同強調 **digitoxin/digoxin** 在已優化 GDMT 之上仍有 **incremental 效益**；既已開始的患者**不要隨意停藥**

Pearl 2 — 新藥當心：tonlamarsen (RAAS antisense)、XXB750 (NPR-1 agonist) phase 2 皆 **target engagement 達標但 BP 終點失敗**——「surrogate ≠ outcome」

Pearl 3 — 結構介入：DOUBLE-CHOICE 證實 ACURATE neo2 的低 PPM 優勢；雖然 valve 下市，但**設計理念** (supra-annular、low radial force) 值得繼承

Pearl 4 — 急性中風新策略：TAPIS 顯示 IVT 後 6 小時內加 7 天 DAPT 可提升功能恢復 (無顯著 ICH) ；ORIENTAL-MeVO 將 thrombectomy 適應症延伸至 MeVO

Pearl 5 — RAAS 與 HFpEF：CADENCE 顯示 sotatercept 跨界 HFpEF-CpcPH ；MOMENTUM-3 **RAASi 分析顯示 LVAD 患者 RAASi 與低 bleeding 相關**——RAAS 在 HF 仍有可挖掘的應用

縮寫對照

縮寫	全稱
ACHD	Adult Congenital Heart Disease
AS / BAV	Aortic Stenosis / Bicuspid Aortic Valve
BPV	Blood Pressure Variability
CABG / MAG / SAG	Coronary Artery Bypass Grafting / Multi / Single Arterial Grafting
CKD	Chronic Kidney Disease
CLTI	Chronic Limb-Threatening Ischemia
CpcPH	Combined Post- and Precapillary Pulmonary Hypertension
DAPT / DOAC	Dual Antiplatelet Therapy / Direct Oral Anticoagulant
DCB / DRS	Drug-Coated Balloon / Drug-eluting Resorbable Scaffold
ERC	Early Rhythm Control
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy
HFrEF / HFpEF	HF with Reduced / Preserved Ejection Fraction
HRAE	Hemocompatibility-Related Adverse Event
IVT / IVL	Intravenous Thrombolysis / Intravascular Lithotripsy
LDC	Low-Dose Combination
LM	Left Main coronary
LVAD	Left Ventricular Assist Device
MeVO	Medium Vessel Occlusion

參考文獻 (1/3)

NEJM

1. Hu W, et al. ORIENTAL-MeVO. *N Engl J Med* 2026;394(19):1894-1904.
2. Ospel JM, Hill MD. Editorial. *N Engl J Med* 2026.

Lancet

3. Wang A, et al. TAPIS. *Lancet* 2026;407(10542):1919-1928.
4. Horn DB, et al. SURMOUNT-MAINTAIN. *Lancet* 2026.

European Heart Journal

5. Bavendiek U, et al. DIGIT-HF AF subgroup. *Eur Heart J* 2026.
6. van der Meer P, et al. DECISION. *Eur Heart J* 2026.
7. Zhao W, et al. SPRINT/ACCORD BPV. *Eur Heart J* 2026.
8. Johnson TW, et al. EAPCI/EBC LM imaging consensus. *Eur Heart J* 2026.
9. Isath A, et al. MOMENTUM-3 RAASi. *Eur Heart J* 2026.
10. Holmgren L, et al. ACHD + AMI. *Eur Heart J* 2026.
11. Lorusso R, et al. AMI mechanical complications SOTA. *Eur Heart J* 2026.
12. Cleland JGF, et al. HF prevalence. *Eur Heart J* 2026.

參考文獻 (2/3)

JACC Family

13. Laffin LJ, et al. KARDINAL. *J Am Coll Cardiol* 2026;87(18):2508-2520.
14. Sung KC, et al. HM-APOLLO. *J Am Coll Cardiol* 2026;87(18):2392-2411.
15. White WB, et al. XxB750. *J Am Coll Cardiol* 2026;87(18):2373-2387.
16. Uppal J, et al. POTS Ivabradine. *J Am Coll Cardiol* 2026.
17. Schenker N, et al. EAST-AFNET 4 CKD. *J Am Coll Cardiol* 2026.
18. Parikh SA, et al. LIFE-BTK 3-yr. *J Am Coll Cardiol* 2026.
19. Schaffer JM, et al. MAG IV analysis. *J Am Coll Cardiol* 2026.
20. Biegus J, et al. Istaroxime SEISMIC pooled. *JACC Heart Fail* 2026.
21. Bos JM, et al. CPVT LCSD. *JACC Clin Electrophysiol* 2026.
22. Lam EL, et al. HDP US 2016-2024. *J Am Coll Cardiol* 2026.

Circulation Family

23. Gombert-Maitland M, et al. CADENCE. *Circulation* 2026;153(19):1446-1459.
24. Lalani C, et al. AGENT post-approval. *Circ Cardiovasc Interv* 2026.
25. Price MJ, et al. RESTORE FIH. *Circ Cardiovasc Interv* 2026.
26. Fabris T, et al. AD-HOC Registry. *Circ Cardiovasc Interv* 2026.
27. Ruel M, et al. AHA Secondary Prevention CABG 2026. *Circulation* 2026.

參考文獻 (3/3)

- 28. Vega RB, et al. Laroprovstat phase 1. [Circulation 2026](#).
- 29. Zimerman A, et al. FOURIER aneurysm. [Circulation 2026;153\(19\):1516-1519](#).
- 30. Przybylski R, et al. Pediatric HCM massive LVH. [Circulation 2026](#).

EuroIntervention (Mainz 2026 Issue)

- 31. Feistritz HJ, et al. DOUBLE-CHOICE. [EuroIntervention 2026;22\(10\):555-565](#).
- 32. Fuertes-Kenneally L, et al. GLUCO-TAVI. [EuroIntervention 2026;22\(10\):545-554](#).
- 33. Kandzari DE, et al. SPYRAL 36-mo. [EuroIntervention 2026;22\(10\):585-593](#).
- 34. Holck EN, et al. OCTOBER LM substudy. [EuroIntervention 2026;22\(10\):566-574](#).
- 35. Emilsson OL, et al. SWEDHEART DOAC+ACS. [EuroIntervention 2026;22\(10\):575-584](#).
- 36. Craig NJ, et al. TAVI timing review. [EuroIntervention 2026;22\(10\):530-544](#).
- 37. Pilgrim T, Cozzi O. Inflammation post-TAVI editorial. [EuroIntervention 2026](#).
- 38. Angiolillo DJ, et al. Prasugrel vs ticagrelor debate. [EuroIntervention 2026](#).
- 39. Blankenberg S, Ludwig S. DOUBLE-CHOICE editorial. [EuroIntervention 2026](#).

外部報導

- 40. ESC Press Office. [DIGIT-HF main trial release](#).
- 41. ACC. [CADENCE: Sotatercept in CpcPH-HFpEF](#).

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考，不構成臨床治療建議。